

면접 발표

흠어진 헬스케어 접점을 측정 가능한 플랫폼 사업으로

대표 프로젝트 성과와 DAI 입사 후 실행 제안

정치성 · 2026.09.16

저는 플랫폼을 크게 시작하지 않고, 하나의 환자 여정에서 성과를 증명한 뒤 확장하겠습니다

01

제가 이해한 DAI

그룹 IT 운영을 넘어 제약·바이오·헬스케어의
AX 성과를 만들어야 하는 전환기

02

제가 제안하는 방향

분산된 진단·모니터링·관리 접점을 **공통**
데이터와 Care Journey로 연결하는 AI
헬스케어 플랫폼

03

제가 실행하는 방식

이해와 선택



설계와 검증



구축과 확장

하나의 우선과제, 측정 가능한 KPI, 검증 이후의 확장

전환 · 운영 · 연동 · 조직 실행 경험을 DAI의 플랫폼 사업화에 적용하겠습니다.

사용자가 할 일과 현장이 처리할 일을 함께 설계해 팀의 실행으로 연결해 왔습니다.

경험 · 도메인	사용자 과제	현장 · 조직 과제	증명한 역량
굿리치 보험 · 인슈어테크	보험분석 후 상담신청	→ 상담 활용 정보의 품질 확인	전환
THK 장기요양 · 돌봄	수급자 자격·구매정보 조회	→ 주문·직배송 및 예외처리	운영
병원 원무 의료기관 · 수납	예약·조회·수납	→ EMR 연동 및 기관별 요구 조율	연동
코나아이 지역화폐 · 결제	지역화폐·카드 이용	→ 3개 팀의 우선순위와 실행 관리	조직 실행

산업은 달랐지만, **고객 여정과 운영 프로세스를 하나의 제품으로 연결**한 경험은 동일합니다.

사용자 행동과 운영 흐름을 바꿔 전환과 처리시간을 개선했습니다.

굿리치 · 보험분석 상담신청

기존 대비

20% 개선

상담신청 전환율

문제	상세 분석결과를 상담 전에 모두 공개해 상담신청 동기가 약하고 이탈 발생
실행	간단 결과는 먼저 제공하고, 상세 리포트는 상담신청 완료 후 제공
결과	상담신청 전환율 기존 대비 20% 개선

Guardrail · 상담 활용 정보의 품질과 설계사 클레임을 함께 점검

THK · 제조사 직배송 운영

약

67% 단축

일일 처리시간 약 6시간 → 약 2시간

문제	재고 미보유 주문을 수기로 확인하고 제조사별 연락과 예외처리에 업무 집중
실행	주문 상태와 담당업무, 예외처리를 구조화하고 관리자 시스템에 반영
결과	고물량 제조사 적용 구간에서 일일 처리시간 약 67% 단축

적용 범위 · 고물량 제조사 적용 구간의 일일 처리업무 기준

DAI 적용 사용자 KPI와 현장 운영 KPI를 함께 설계하겠습니다.

기존 시스템을 활용하고, 복잡한 이해관계자를 **실행 가능한 범위**로 정리했습니다.

병원 원무

기존 EMR API 연동



- 기존 **EMR API**의 데이터와 기능을 재사용
- 병원 · EMR사 · 개발조직의 요구사항 조율
- 기관별 차이를 확인하고 공통화 가능 범위를 검토
- 환자가 쓰는 화면과 원무팀이 처리할 업무를 함께 설계

기존 자산 활용

기관별 차이 조율

공통화 검토

코나아이

3개 팀 실행 관리

- 코나카드는 직접 검직, 지역화폐·모빌리티는 팀장 중심 운영
- 외부 약속, 법률·운영 위험, 공통효과를 기준으로 우선순위 결정
- PRD의 목적·KPI와 상세기획 연결 확인
- 어려운 요구는 **범위·일정·인력의 선택안**으로 경영진에게 보고

우선순위

RACI

경영진 의사결정

실행관리

DAI 적용 계열사, 의료기관, 기술 파트너의 요구를 **하나의 제품 범위와 책임구조**로 정리하겠습니다.

DAI의 기회는 솔루션을 하나 더 만드는 것이 아니라, 그룹의 접점을 플랫폼 자산으로 전환하는 데 있습니다.

DAI의 전환

- 기존 IT 구축·운영 중심
- **AI 기반 AX 혁신 파트너로 전환**
- 기술 도입보다 업무방식과 의사결정의 변화 추구
- 그룹 내부 경험을 외부 사업으로 확장해야 하는 단계

그룹의 기반

- 제약·바이오 도메인과 병원 채널
- 진단, 모니터링, 복약·관리 솔루션
- GMP · CSV · Data Integrity 역량
- AI·데이터 및 플랫폼 개발조직

첫 문제 가설

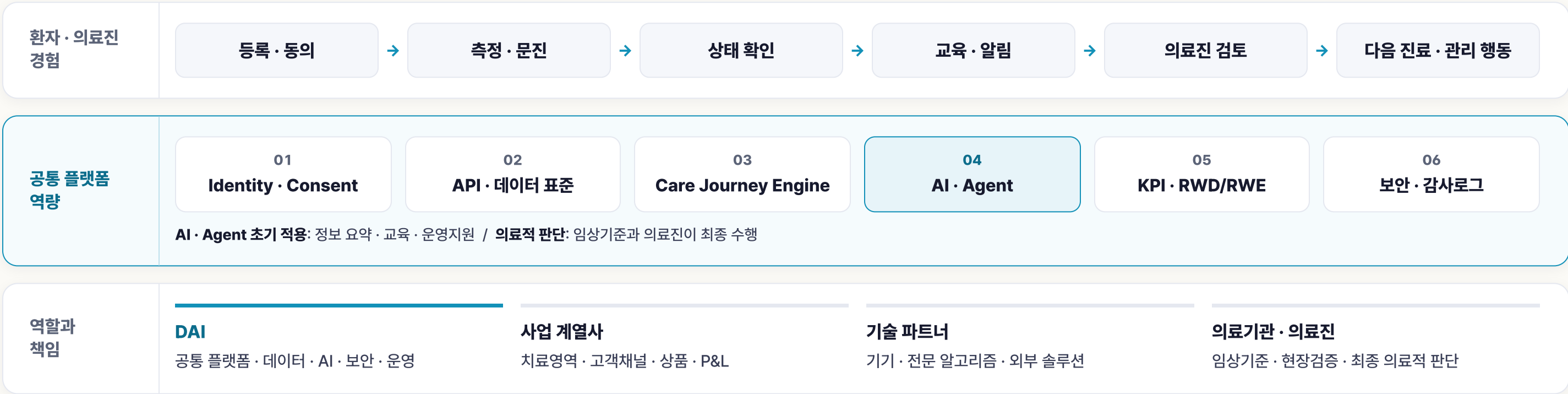
공개자료 기반 가설 · 입사 후 확인

- 제품과 파트너는 존재하지만 환자 여정은 개별 접점으로 운영될 수 있음
- 서비스마다 동의·권한·데이터·운영체계를 반복 구축할 가능성
- 실제 연결 가능성은 **데이터·API·계약 조건 확인 필요**
- 플랫폼 구축 자체보다 환자·의료진·사업 KPI 증명이 우선

공통 플랫폼은 먼저 크게 구축하는 인프라가 아니라, 첫 사용사례를 해결하며 축적하는 재사용 자산이어야 합니다.

DA Health Loop

진단·모니터링·관리를 다음 행동과 근거로 연결합니다.



하나의 공통 플랫폼을 먼저 만드는 것이 아니라, 하나의 환자 여정에서 검증된 기능을 공통 플랫폼 자산으로 축적합니다.

첫 과제는 연결하기 쉬운 제품이 아니라, 성과와 **지불 가능성**을 증명할 수 있는 **환자 여정**으로 선택하겠습니다.

사용사례 Scorecard

- 1 환자·의료진 문제가 충분히 큰가
- 2 그룹이 고객·채널·도메인 우위를 갖는가
- 3 데이터·API·계약상 연결이 가능한가
- 4 규제와 안전 리스크를 통제할 수 있는가
- 5 비용을 지불할 고객과 반복 수익 가능성이 있는가

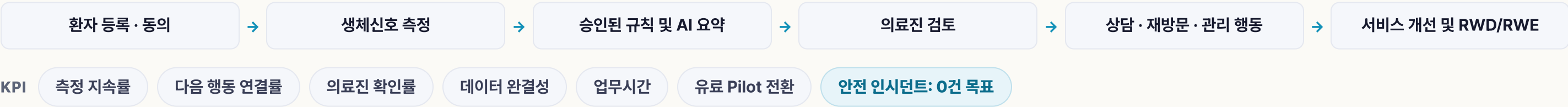
첫 검증 후보

하이카디 기반 심혈관 모니터링·추적관리 Care Loop

- 공개적으로 확인되는 병원 도입 기반
- 웨어러블과 RWD/RWE 활용 가능성
- 환자와 의료진이 모두 참여하는 명확한 Journey
- 동아ST의 병원 채널과 DAI의 플랫폼 역량 결합 가능성

확정안이 아니라 첫 검증 후보입니다. 데이터·API 권리, 병원 수요, 규제, 지불 의사를 확인한 뒤 우선순위를 확정합니다.

환자 여정 예시



입사 후 세 단계로 판단하고 실행하겠습니다.

1 이해와 선택 무엇을 먼저 해결해야 하며, 그룹이 이길 수 있는 영역은 어디인가? 실행 - 환자·의료진·사업부서·개발조직 인터뷰 - 기존 제품·데이터·API·계약·비용 구조 파악 - 개인정보·의료기기·보안 요구사항 확인 - 사용자·운영·사업 KPI 기준선 확인 - 후보 사용사례를 Scorecard로 비교 산출물 - 해결할 문제와 기대성과 합의 - 우선 사용사례와 Pilot 후보 - 이해관계자 및 RACI 초안 - 미확인 가정과 주요 리스크 목록 진행 판단 가치·실행 가능성·지불 가능성이 확인된 과제만 다음 단계로 진행	2 설계와 검증 환자와 의료진이 실제로 사용할 수 있고, 기술·규제·사업 조건을 충족하는가? 실행 - 환자·의료진 Journey와 PRD 작성 - DAI·계열사·파트너 역할 확정 - Build vs Buy 및 목표 아키텍처 결정 - 동의·권한·데이터 표준 설계 - 비진단 Prototype·핵심 연동 기술검증을 Design Partner와 수행 산출물 - 검증된 Prototype과 핵심 데이터 연동 결과 - 규제·보안 검토 결과 - Pilot 범위·KPI·비용 및 사업성 검토 - 진행·수정·보류 추천안 진행 판단 사용성·연동·규제 대응·사업성이 확인된 경우에만 구축	3 구축과 확장 실제 운영에서 성과가 발생하며, 다른 기관과 질환에도 재사용할 수 있는가? 실행 - 제한된 범위 Pilot 운영 · 환자·의료진·운영·사업 KPI 측정 - 장애·오류·누락·사용자 피드백 관리 - 유료 전환 및 반복 수익 가능성 검증 - 동의·데이터·Journey·AI 기능을 플랫폼 자산화 - 두 번째 기관 또는 질환으로 확장 검토 산출물 - KPI Dashboard와 운영 결과 - 유료 전환 또는 사업 지속 판단 - 재사용 가능한 공통 플랫폼 모듈 - 확대·보완·중단에 대한 경영진 추천안 진행 판단 성과·단위경제성 확인 시 확대, 미달 시 범위 수정·중단
---	--	--

경영진에게는 **선택의 근거와 추천안**을, 실행조직에는 **명확한 범위와 판단기준**을 제시하겠습니다.

맺음말

기술을 도입하는 팀장이 아니라, 비즈니스 결과를 끝까지 설명하는 팀장이 되겠습니다

01

전환

사용자 행동을 성과로 전환

02

구조화

현장 업무를 제품과 데이터로 구조화

03

연동

기존 시스템과 파트너를 플랫폼으로 연결

04

실행

우선순위를 정하고 결과까지 책임

하나의 우선과제에서 성과를 증명하고, 검증된 기능을 **DAI의 플랫폼 자산**과 반복 가능한 사업으로 만들겠습니다.